TREMFYA® nella malattia di Crohn
IL-23
CD64+

TREMFYA® è indicato per il trattamento di pazienti adulti con malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un trattamento biologico[1]

Entrambi i regimi di TREMFYA® sono risultati superiori al placebo per l'endpoint della risposta clinica alla Settimana 12 e della remissione clinica alla Settimana 48 nello studio GALAXI-2, tale dato è stato osservato in 80 su 146 (55%) partecipanti nel gruppo TREMFYA® 200 mg, 70 su 143 (49%) nel gruppo TREMFYA® 100 mg e 9 su 76 (12%) nel gruppo placebo (differenza di trattamento aggiustata 43% [IC 95% 32-54] nel gruppo TREMFYA® 200 mg e 38% [27-49] nel gruppo TREMFYA® 100 mg; p<0,0001), e nello studio GALAXI-3, tale dato è stato osservato in 72 su 150 (48%) partecipanti nel gruppo TREMFYA® 200 mg, 67 su 143 (47%) nel gruppo TREMFYA® 100 mg, e 9 su 72 (13%) nel gruppo placebo (35% [24-46] e 34% [23-45]; p<0,0001)[2]

Inoltre, TREMFYA® ha dimostrato superiorità rispetto a ustekinumab alla Settimana 48 per quanto riguarda i risultati endoscopici che sono associati a un miglior controllo della malattia a lungo termine[2]

Efficacia alla Settimana 12

Tassi di remissione clinica alla Settimana 12 con induzione di TREMFYA® EV: tutti i partecipanti, partecipanti senza una precedente esposizione alle terapie biologiche (BIO-naïve), e partecipanti con una storia di risposta inadeguata o di intolleranza alle terapie biologiche (BIO-IR, dati aggregati di GALAXI-2 e -3)[3]

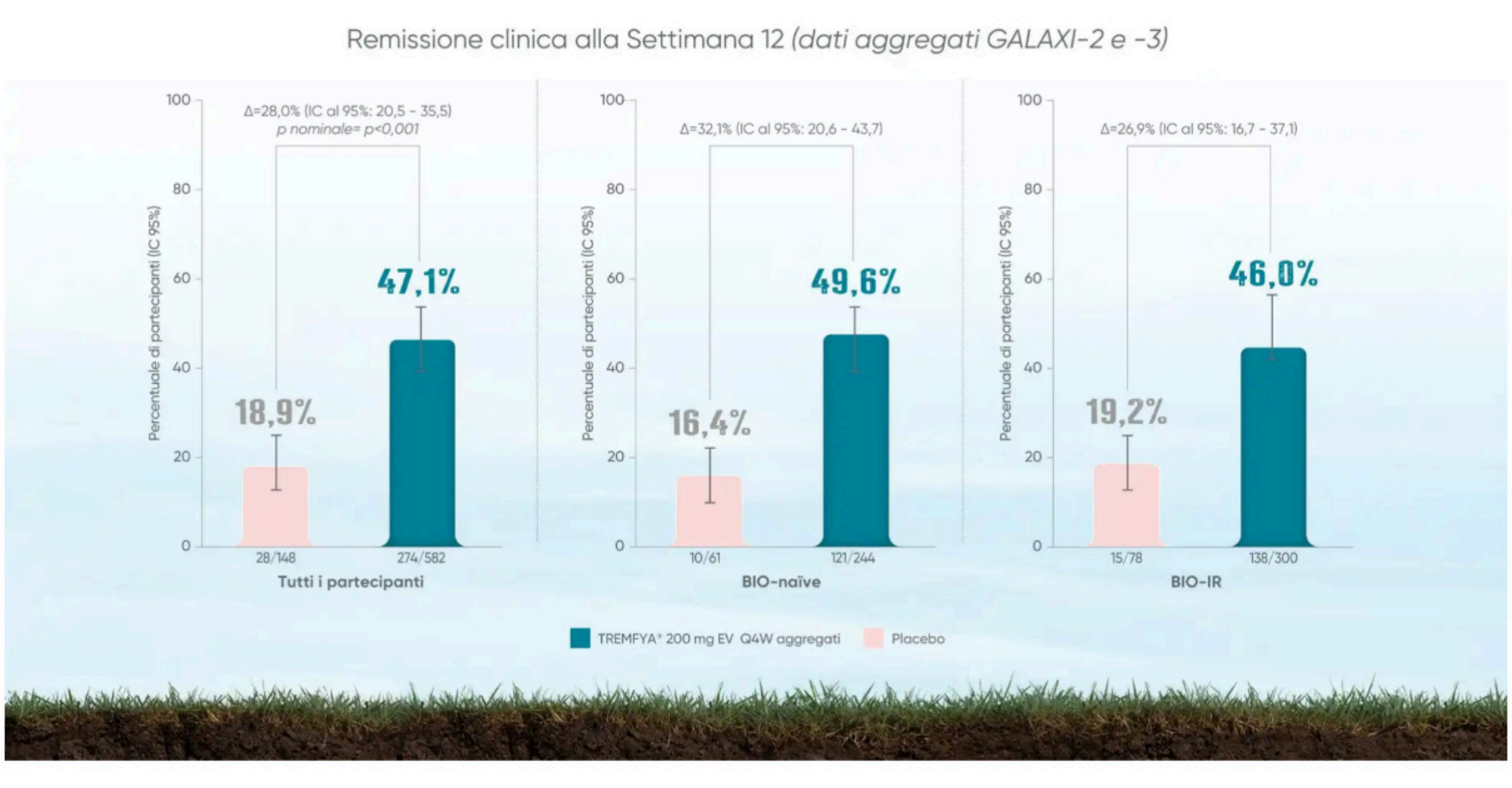

Figura di Rif. 3

Dati presentati come n (%); % (differenza di trattamento aggiustata rispetto al placebo). Remissione clinica: punteggio CDAI<150; risposta endoscopica: miglioramento ≥50% dal basale nel punteggio SES-CD o punteggio SES-CD ≤2.[3]

Risposta endoscopica alla Settimana 12 con induzione EV con TREMFYA®: tutti i partecipanti, i partecipanti senza precedente esposizione a terapie biologiche (BIO-naïve) e i partecipanti con una storia di risposta inadeguata o intolleranza alle terapie biologiche (BIO-IR) (dati aggregati GALAXI-2 e -3)[3]

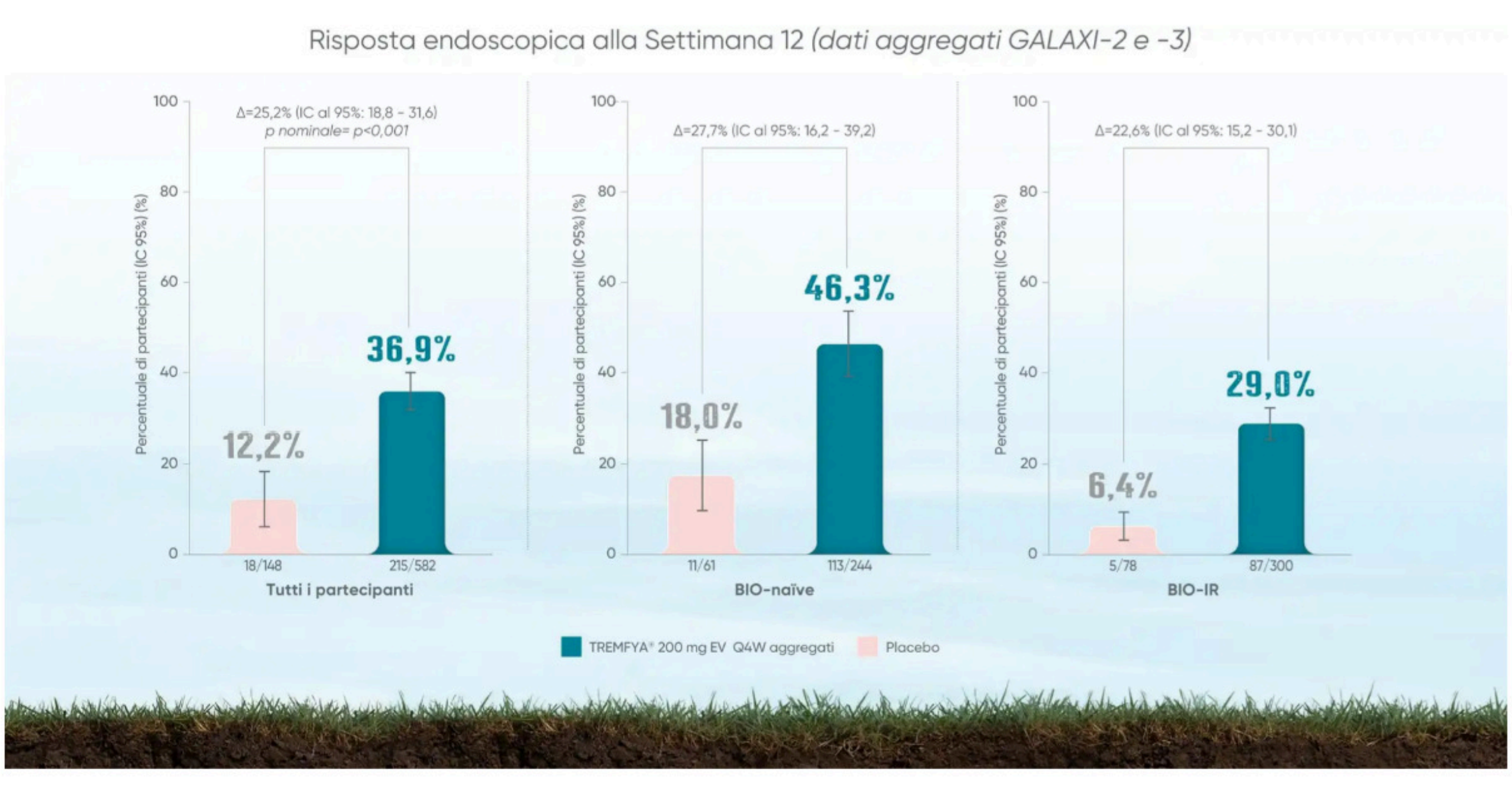

Figura di Rif. 3

Dati presentati come n (%); % (differenza di trattamento aggiustata rispetto al placebo). Remissione clinica: punteggio CDAI<150; risposta endoscopica: miglioramento ≥50% dal basale nel punteggio Simple Endoscopic Score for Crohn's Disease (SES-CD o punteggio SES-CD ≤2).[3]

STUDIO GRAVITI

Alla Settimana 12, percentuali significativamente maggiori di partecipanti nel gruppo combinato TREMFYA® 400 mg SC ogni 4 settimane hanno raggiunto la remissione clinica rispetto al placebo (56,1% rispetto a 21,4%; Δ=34,9; IC 95%, 25,1-44,6; p<0,001).[4]

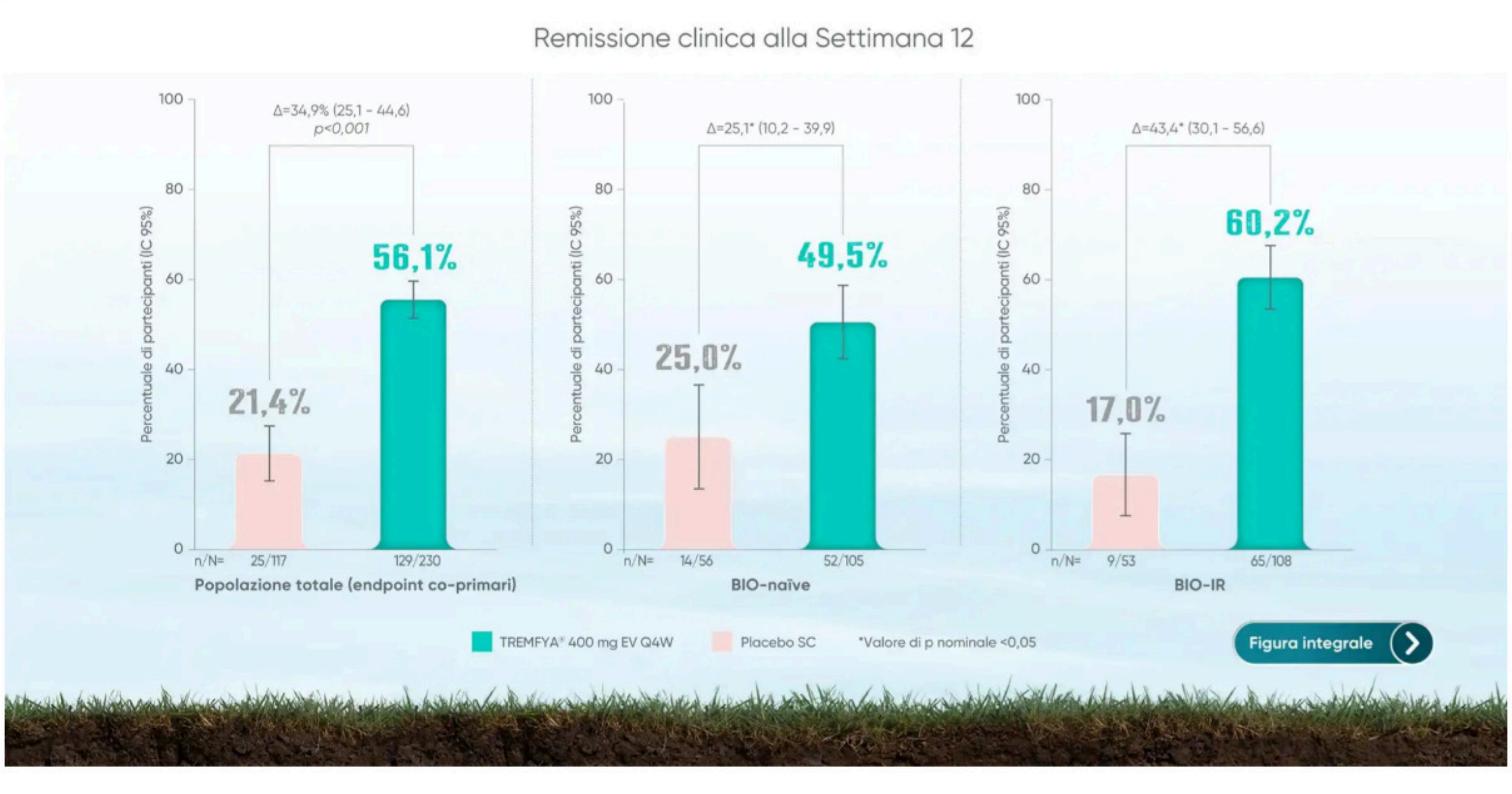

Figura 2a di Rif. 4

Alla Settimana 12, percentuali significativamente maggiori di partecipanti nel gruppo combinato TREMFYA® 400 mg SC ogni 4 settimane hanno raggiunto la risposta endoscopica rispetto al placebo (41,3% rispetto a 21,4%; Δ=19,9; IC 95%, 10,2-29,6; p<0,001).[4]

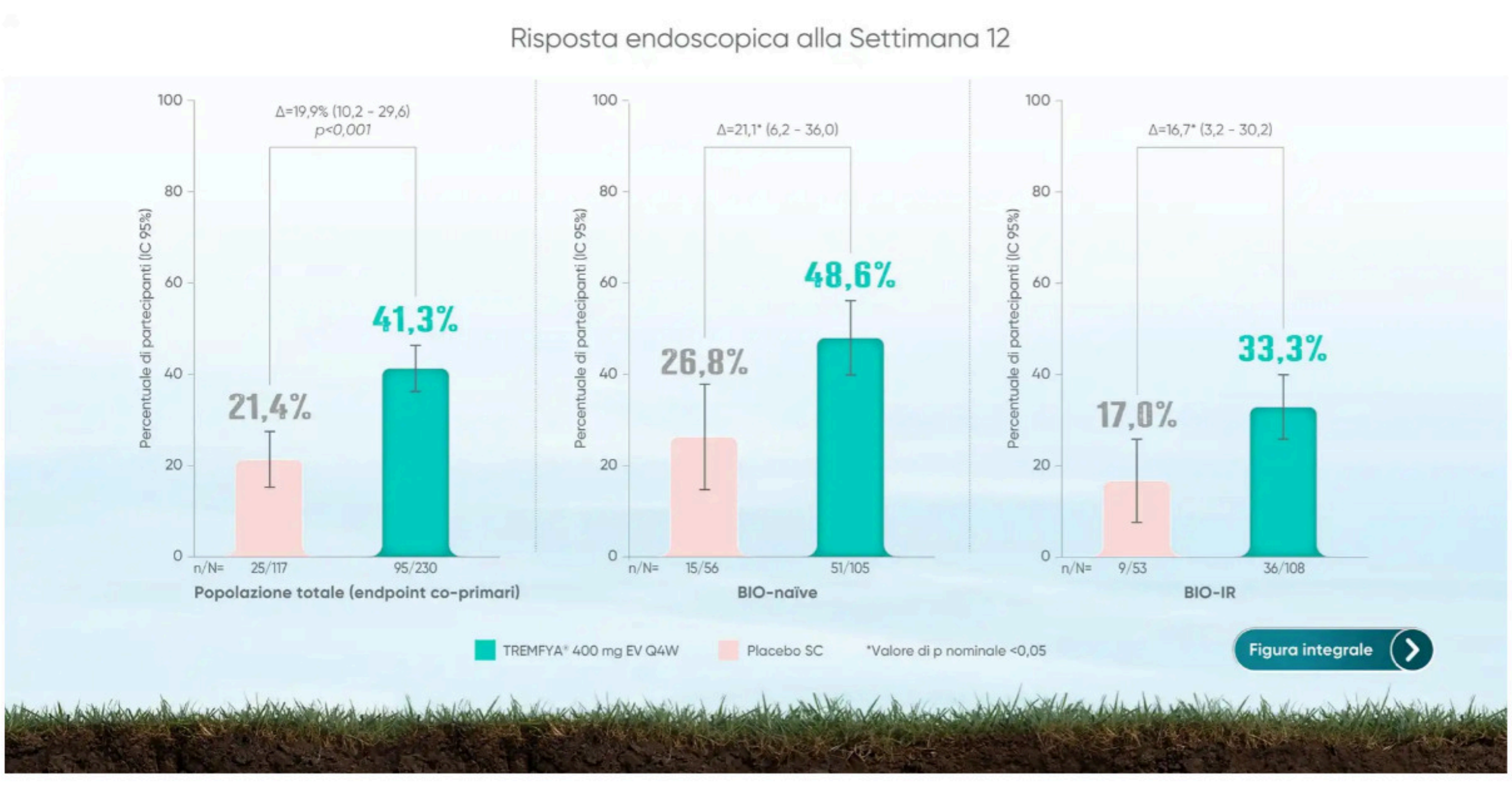

Figura 2a di Rif. 4

Efficacia alla Settimana 48

Per i principali endpoint secondari che valutano l'efficacia a lungo termine di TREMFYA® rispetto al placebo, ciascun regime di TREMFYA® è risultato statisticamente superiore in entrambi gli studi[2]

Efficacia a lungo termine di TREMFYA® rispetto al placebo misurata mediante i principali endpoint secondari degli studi GALAXI-2 e -3[2]

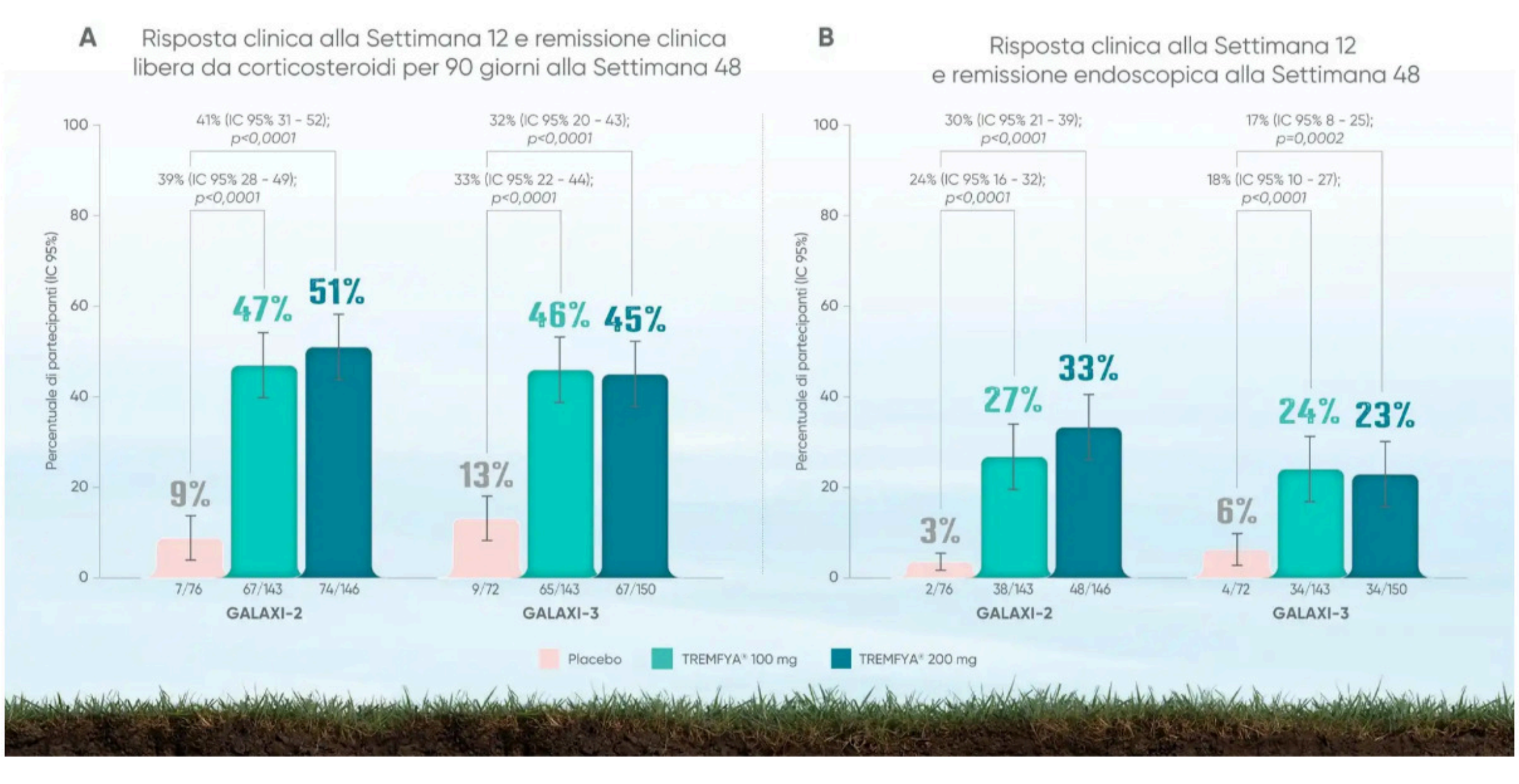

Figura 3 di Rif. 2

L'efficacia a lungo termine è stata valutata con due endpoint secondari compositi: risposta clinica alla Settimana 12 e remissione clinica senza corticosteroidi per 90 giorni alla Settimana 48 (A) e risposta clinica alla Settimana 12 e remissione endoscopica alla Settimana 48 (B). La risposta clinica è stata definita come una riduzione di ≥100 punti del punteggio CDAI dal basale o CDAI <150. La remissione clinica senza corticosteroidi è stata definita come un punteggio CDAI <150 a un timepoint designato e nessuna somministrazione di corticosteroidi per 90 giorni prima di tale timepoint. La remissione endoscopica è stata definita come un punteggio SES-CD ≤4, una riduzione ≥2 punti rispetto al basale e nessun sotto-punteggio SES-CD >1 in nessun singolo componente. L'efficacia di TREMFYA® è confrontata con quella del placebo; sono presentate le differenze di trattamento aggiustate con IC 95%. I valori immediatamente sopra le barre dell'IC 95% indicano la percentuale di partecipanti che hanno raggiunto l'endpoint.[2]

Analisi prespecificate e controllate per molteplicità dei dati aggregati GALAXI-2 e -3 hanno mostrato che entrambi i regimi di TREMFYA® erano statisticamente superiori (p<0,05) a ustekinumab alla Settimana 48 per risposta endoscopica, remissione endoscopica, la combinazione di remissione clinica e risposta endoscopica e remissione profonda, che rappresenta la combinazione di remissione clinica e remissione endoscopica[2]

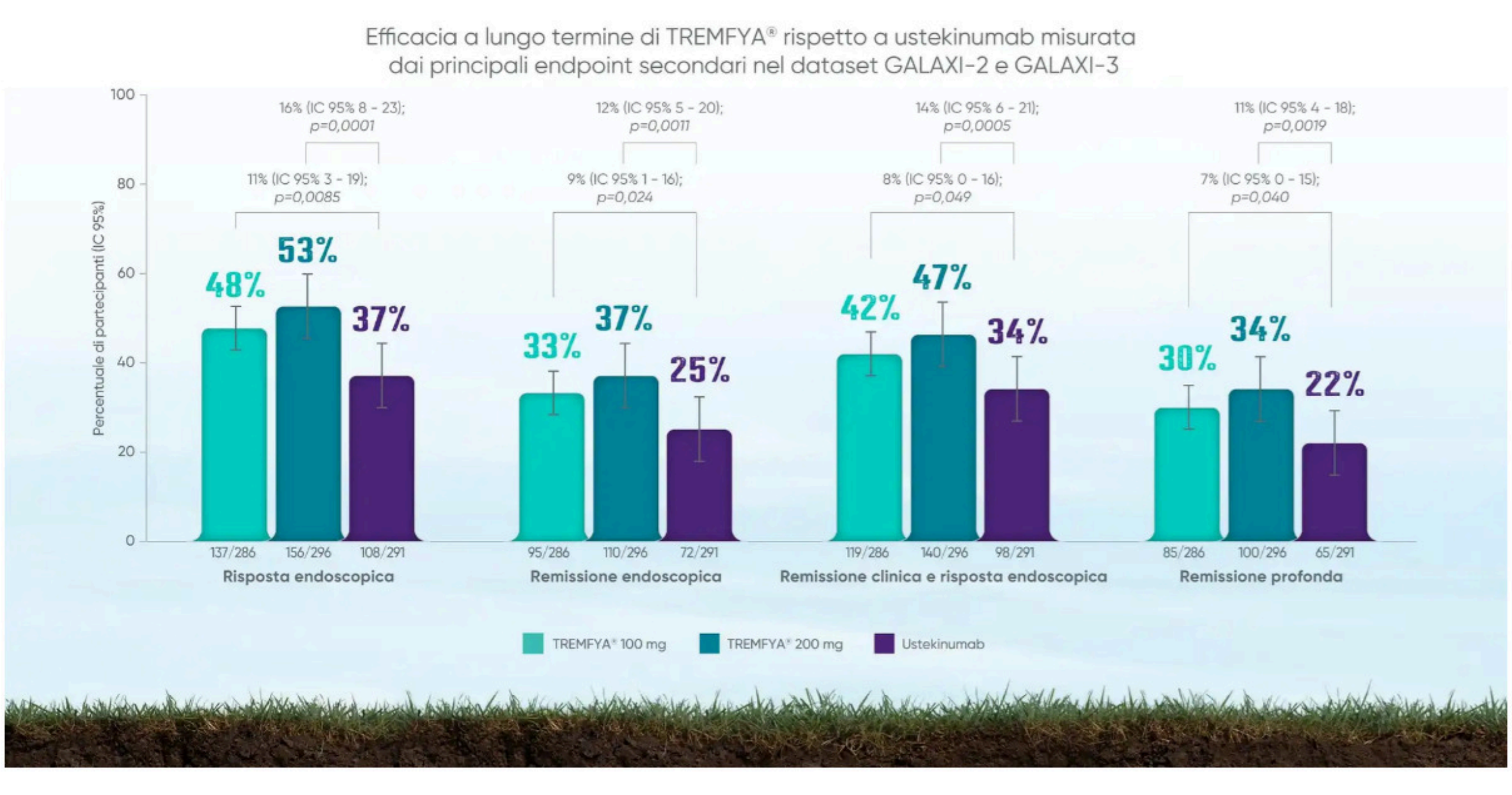

Figura 4 di Rif. 2

Sono presentati 4 endpoint secondari: risposta endoscopica (miglioramento ≥50% rispetto al basale nel punteggio SES-CD o punteggio SES-CD ≤2), remissione endoscopica (punteggio SES-CD ≤4, riduzione ≥2 punti rispetto al basale e nessun sotto-punteggio SES-CD >1 in nessun singolo componente), remissione clinica (punteggio CDAI <150) e risposta endoscopica e remissione profonda (remissione clinica e remissione endoscopica). I valori immediatamente sopra le barre dell'IC 95% indicano la percentuale di partecipanti che hanno raggiunto l'endpoint.[2]

Abbreviazioni

BIO-IR: precedente risposta inadeguata/di intolleranza alle terapie biologiche per la malattia di Crohn; **BIO-naïve:** nessuna precedente esposizione alle terapie biologiche per la malattia di Crohn; **CD:** Crohn's disease, malattia di Crohn; **CDAI:** Crohn's Disease Activity Index, indice di attività della malattia di Crohn; **EV:** per via endovenosa; **IC:** intervallo di confidenza; **PRO-2:** patient-reported outcome-2; **Q4W:** ogni 4 settimane; **SC:** per via sottocutanea; **SES-CD:** Simple Endoscopic Score for Crohn's Disease, punteggio endoscopico semplice per la della malattia di Crohn.

TREMFYA 200 mg - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino - 20 ml (10 mg/ml) - 1 flaconcino - AIC 045772050 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 200 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita in penna preriempita (PushPen) - 2 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita - AIC 045772086 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 200 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita - 2 ml (100 mg/ml) - 2 (2 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla) - AIC 045772074 - Prezzo al pubblico: € 7.545,14*

TREMFYA 200 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita in penna preriempita (PushPen) - 2 ml (100 mg/ml) - 2 (2 x 1) penne preriempite (confezione multipla) - AIC 045772098 - Prezzo al pubblico: € 7.545,14*

* Sono fatte salve eventuali riduzioni e/o modifiche imposte dall'Autorità Sanitaria competente.

Classe di rimborsabilità: H

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, gastroenterologo (RRL).

Le confezioni di Tremfya sopracitate sono rimborsate dal SSN per le indicazioni malattia di Crohn e colite ulcerosa come da scheda di prescrizione cartacea.

L'induzione sottocute è al momento rimborsata solo in malattia di Crohn.

TREMFYA 100 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita - 1 ml (100 mg/ml) - 1 siringa preriempita - AIC n. 045772011 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 100 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - penna preriempita - 1 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita - AIC n. 045772023 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 100 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita in penna preriempita (PushPen) - 1 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita - AIC 045772100 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

* Sono fatte salve eventuali riduzioni e/o modifiche imposte dall'Autorità Sanitaria competente.

Classe di rimborsabilità: H

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo, reumatologo, internista, gastroenterologo (RRL).

Le confezioni di Tremfya sopracitate sono rimborsate dal SSN per le indicazioni psoriasi a placche, artrite psoriasica, malattia di Crohn e colite ulcerosa.

Rimborsabilità delle indicazioni psoriasi a placche, malattia di Crohn e colite ulcerosa come da scheda di prescrizione cartacea.

RCP TREMFYA 100 mg OnePress e PushPen
SCARICA

RCP TREMFYA 100 mg Siringa
SCARICA

RCP TREMFYA 200 mg PFS/PFP
SCARICA

RCP TREMFYA 200 mg EV
SCARICA

Bibliografia

1. TREMFYA® Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
2. Panaccione R, et al. Lancet. 2025;406(10501):358-375.
3. Panaccione R, et al. Lancet. 2025;406(10501):358-375 Materiale supplementare.
4. Hart A, et al. Gastroenterology. 2025;169(2):308-325.

Codice AIFA: CP-603519

Pubblicità rivolta ai medici depositata in AIFA il: xx/xx/2026

VIETATA LA DISTRIBUZIONE/ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

© Janssen-Cilag S.p.A., società del gruppo Johnson & Johnson, viale Fulvio Testi 280/6, 20126 Milano. Questo sito è pubblicato da Janssen-Cilag SpA che è l'unica responsabile dei contenuti presenti. Cap. Soc. €25.000.000,00 i.v. - Registro Imprese MI e Codice Fiscale 00962280590 - Partita IVA 02707070963 - R.E.A. 1454254. Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Società Johnson & Johnson. Questo sito è destinato ai visitatori residenti in Italia.

Ultimo aggiornamento 25 ottobre 2026

FIGURA 2 DI RIF. 4

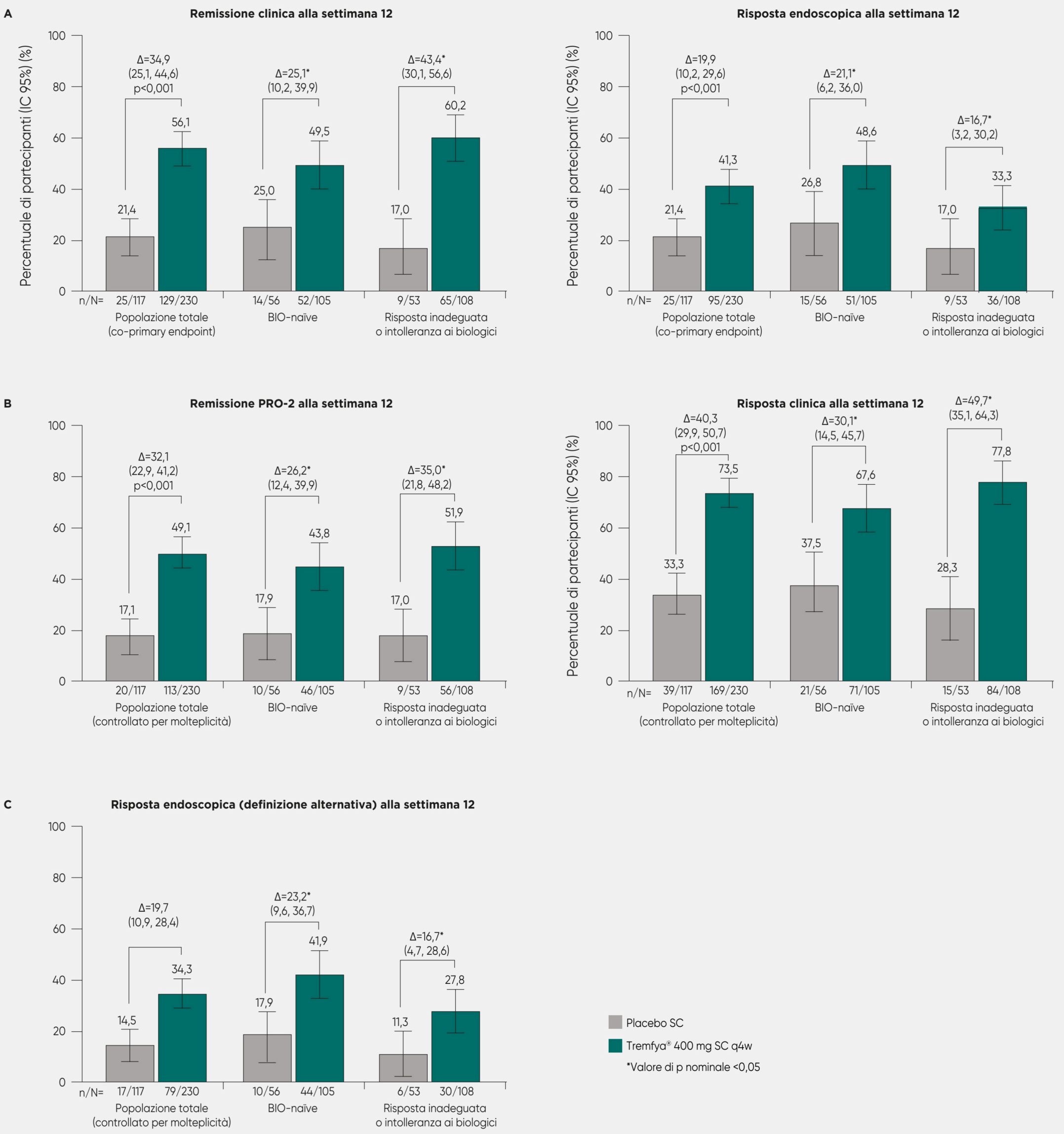

Figura 2 di Rif. 4.
(A) Endpoint co-primari: remissione clinica (CDAI <150) alla settimana 12 e risposta endoscopica (miglioramento del ≥50% rispetto al basale nel punteggio SES-CD) alla settimana 12.

(B) Remissione PRO-2 (punteggio medio giornaliero del dolore addominale ≤1 e punteggio medio giornaliero della frequenza di evacuazione ≤3 e nessun peggioramento del dolore addominale o della frequenza di evacuazione delle feci rispetto al basale) alla settimana 12 e risposta clinica (riduzione di ≥100 punti rispetto al basale nel punteggio CDAI o punteggio CDAI <150) alla settimana 12.

(C) Definizione alternativa di risposta endoscopica (miglioramento >50% rispetto al basale nel punteggio SES-CD o punteggio SES-CD ≤2) alla settimana 12.
I partecipanti che avevano subito un intervento chirurgico correlato alla malattia di Crohn, una modifica proibita nei farmaci concomitanti per la malattia di Crohn, hanno interrotto il farmaco in studio a causa della mancanza di efficacia o di un evento avverso di peggioramento della malattia di Crohn, o interruzione del farmaco in studio a causa di infezione da COVID-19 o per motivi diversi dalla mancanza di efficacia o da un evento avverso di peggioramento della malattia di Crohn, motivi correlati a COVID-19 o crisi regionale, prima del momento di analisi designato sono stati considerati come non aver raggiunto l'endpoint binario da quel momento in poi. I dati osservati dei partecipanti che avevano interrotto il farmaco in studio a causa di motivi correlati a COVID-19 (esclusa l'infezione da COVID-19) o crisi regionale sono stati utilizzati, se disponibili, per determinare lo stato di responder da quel momento in poi.